20. PRATIQUE DE STRUCTURATION DU SYSTEME VASCULAIRE

DURÉE : 02:50 FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo vous plonge dans la pratique de structuration du système vasculaire, en mettant l'accent sur l'importance de trouver et d'émerger le neutre chez le patient. Grâce à des techniques telles que le champ micro-cristallin et l'immobilité dynamique, vous apprendrez à créer un environnement propice à la guérison en intégrant les concepts de silence dans la pièce et mobilité au niveau des piliers diaphragmatiques. La session se concentre aussi sur la cavité amniotique et l'importance de la respiration primaire comme souffle de vie, essentielle pour une approche thérapeutique holistique. Cette approche offre une opportunité d'apprendre non seulement comment intervenir, mais aussi comment laisser les processus naturels du corps s'épanouir.

PRATIQUE DE STRUCTURATION DU SYSTÈME VASCULAIRE

Nous allons rechercher le **silence** de la zone C par rapport à la zone A sur le plan diaphragmatique. Il y a un point de silence dans la pièce.

Je vais vous guider à un moment donné. Nous partirons du **neutre** et laisserons petit à petit le neutre du patient se développer. Nous allons nous concentrer sur le **champ micro-cristallin**, en prenant tout l'espace.

Pour avoir une action thérapeutique la plus efficace possible, il est essentiel d'atteindre un neutre. Ensuite, il est important de faire émerger ce neutre chez le patient. C'est un processus qui doit **maturer**.

Pour cela, il faut le **meeting point**, le point de rencontre. Une fois que j'ai établi ce point de rencontre, la personne, en confiance, peut progressivement se désengager, se laisser aller et aller vers son neutre.

Petit à petit, ces deux neutres vont commencer à se mélanger. Une fois que ces deux neutres se mélangent, un espace, une **émergence** plus visible peut apparaître : ce qu'on appelle la **respiration primaire**.

La respiration primaire n'est pas uniquement présente dans le corps, elle est omniprésente, un peu comme le **souffle de vie**.

Nous allons nous concentrer sur la **cavité amniotique**, cette zone B. En même temps, nous dissocierons notre attention pour nous focaliser sur les **piliers diaphragmatiques**.

Le point le plus fixe de mon diaphragme est constitué par les piliers. Nous allons constater que, finalement, nous atteindrons un neutre. Ce sont des points d'appui énormes, presque un point silencieux.

Avec un peu de patience, nous ferons émerger le neutre de manière plus large, en utilisant également le **silence cristallin**.

Nous parlerons plutôt de l'**immobilité cristalline** de la pièce. Il existe une forme d'immobilité dans la zone C que nous devons percevoir. Nous laisserons le corps se centrer par rapport à cette zone C.

Bien que cela puisse sembler subtil, cela se fera naturellement sur un plan **fluidique**, presque électrique.

Ensuite, nous commencerons à faire confondre ce silence de la pièce, ou cette immobilité dynamique de la pièce, avec l'immobilité dynamique au niveau des piliers diaphragmatiques.

Tout en étant conscient de la cavité amniotique et de l'intégration de ma **vésicule vitelline** pour former mon système veineux, nous allons faire confondre ce silence de la pièce avec l'immobilité dynamique.

Il est crucial de vous abandonner totalement à la **respiration primaire**, au mouvement présent, à la marée, c'est-à-dire à la **force thérapeutique**, à la puissance.

Laissez petit à petit voir ce que cela peut engendrer. Le but, dans le **non-agir**, est de ne pas induire, mais de faire confiance à l'ostéopathe.